Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Критерии диагноза 2

2.3 Степень тяжести 3

2.4 Классификация 3

2.5 Дифференциальная диагностика 3

3. Диагностика 3

4. Лечение 4

4.1 Показания к антибактериальной терапии 4

4.2 Дозы стартовой терапии 5

4.3 Парентеральная терапия при тяжёлом течении 6

4.4 Местная и симптоматическая терапия 6

4.5 Хирургическое лечение 7

4.6 Профилактика 7

4.7 Особые случаи 8

5. Показания к госпитализации. Осложнения 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Исправления по результатам сверки с PDF 8

6.2 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

6.3 Шкалы доказательности 9

1. Основные положения

- Острый синусит является острым воспалением слизистой оболочки носа и околоносовых пазух продолжительностью менее 12 недель. Заболевание характеризуется наличием не менее двух симптомов: заложенность носа, выделения из носа или носоглотки, ощущение давления или боль в области лица, снижение или потеря обоняния.
- В 90–98% случаев возбудителями синусита являются вирусы, на долю бактериального синусита приходится лишь 2–10%.
- Системная антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом течении синусита. При лёгком течении к антибиотикам прибегают только при рецидивирующем синусите с сохранением симптомов 5–7 дней и более, при тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефиците.
- При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин). При отсутствии заметного эффекта в течение 3 дней препарат заменяется.
- Сосудосуживающие капли применяют не более 5–7 дней; рекомендуется промывание полости носа солевыми растворами, пациентам старше 12 лет возможно назначение интраназальных глюкокортикостероидов.
- Показаниями к госпитализации являются тяжёлое течение, орбитальные или внутричерепные осложнения, отсутствие улучшения на фоне системной антибактериальной терапии в течение 3–5 дней, а также ухудшение состояния в любой момент.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит является острым воспалением слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух продолжительностью менее 12 недель. Заболевание характеризуется наличием не менее двух симптомов: затруднение носового дыхания, выделения из носа или носоглотки, ощущение давления или боль в области лица, снижение или потеря обоняния. Часть симптомов может быть заменена данными риноскопии, эндоскопии или компьютерной томографии (КТ).

У детей отмечается внезапное появление не менее двух симптомов: заложенность носа, бесцветные или светлые выделения, кашель в дневное или ночное время. Симптомы должны полностью регрессировать в течение 12 недель.

Синусит считается рецидивирующим при 4 эпизодах и более за последний год, если между эпизодами имеются периоды не менее 8 недель без симптомов и без лечения.

Острый поствирусный синусит диагностируется при сохранении симптомов более 10 дней после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и отсутствии признаков бактериального синусита. Как правило, он протекает легче и разрешается без антибактериальной терапии.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых заболевание начинается остро, отмечаются два симптома и более, причём одним из них является заложенность носа или выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки. Возможны боль или ощущение давления в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Продолжительность заболевания не превышает 12 недель.

У детей заболевание начинается остро, отмечаются не менее двух симптомов: заложенность носа, выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки, или кашель. Продолжительность заболевания не превышает 12 недель.

Предварительный диагноз подтверждается оториноларингологом по данным риноскопии или эндоскопии (гнойное отделяемое или отёк в области остиомеатального комплекса) либо КТ.

Болевой синдром может отсутствовать. При верхнечелюстном синусите боль локализуется в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья, и может иррадиировать в верхние зубы. Для сфеноидита характерна боль в центре головы и в затылочной области (каскообразная боль).

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или выраженным затруднением носового дыхания.

2.3 Степень тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Лихорадка отсутствует. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Головная боль в проекции околоносовых пазух (ОНП) отсутствует. Осложнений нет
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Ощущение тяжести в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Внутричерепные и орбитальные осложнения отсутствуют
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, травматический, грибковый (в виде острого процесса встречается крайне редко) и смешанный синусит. Изолированный бактериальный синусит встречается редко; как правило, имеет место сочетание вирусов или вирусов и бактерий.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Поражение всех пазух одной половины носа обозначается как гемисинусит, обеих половин как пансинусит.

2.5 Дифференциальная диагностика

У взрослых острый синусит дифференцируют с обострением хронического риносинусита, аллергическим и хроническими ринитами, у детей также с аденоидитом и инородным телом полости носа.

У детей дошкольного возраста при отсутствии осложнений и признаков бактериального синусита в качестве основного диагноза целесообразно указывать аденоидит или острый назофарингит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Всем пациентам выполняют общий осмотр и стандартный осмотр ЛОР-органов.

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки выполняют для оценки их состояния и дифференциальной диагностики.

В большинстве случаев оно не даёт дополнительной информации по сравнению с передней и средней риноскопией, однако позволяет, например, дифференцировать сфеноидит и аденоидит.

Спиральная КТ околоносовых пазух показана при подозрении на внутричерепные или орбитальные осложнения, при затяжном тяжёлом течении и в сложных диагностических случаях.

Рентгенографию околоносовых пазух выполняют при среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также в сложных случаях при невозможности выполнения КТ.

Данные рентгенографии и КТ околоносовых пазух совпадают лишь в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи в 77%.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) пазух используют при подозрении на верхнечелюстной или лобный синусит, если рентгенография и КТ невозможны.

Развёрнутый общий анализ крови необходим при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Лейкоцитоз с нейтрофилёзом не является доказательством бактериального синусита, однако его нарастание при повторном исследовании позволяет решить вопрос о назначении антибиотиков.

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого с определением чувствительности к антибиотикам выполняют в стационаре при среднетяжёлом и тяжёлом течении, при затяжном течении и неэффективности эмпирической антибактериальной терапии.

Материал забирается при пункции пазухи иглой Куликовского. Посев из носового хода неинформативен вследствие попадания в материал посторонней микрофлоры.

Другие исследования не показаны.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Показания к антибактериальной терапии

Взрослым антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком течении антибиотики применяют только при рецидивирующем синусите с сохранением симптомов 5–7 дней и более, а также при тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарном диабете) и иммунодефиците.

О бактериальном синусите свидетельствуют три признака и более: гнойные выделения или выделения только из одной половины носа в течение 3 дней и более; головная боль или ощущение давления в проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температура тела 38,0 °C и выше; «вторая волна» заболевания; лейкоцитоз выше 15×10^9/л. На бактериальную этиологию указывают также выраженные с самого начала симптомы, сохраняющиеся 3–4 дня и угрожающие развитием орбитальных или внутричерепных осложнений.

Детям антибактериальная терапия показана при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком течении антибиотики необходимы при наличии хотя бы одного из условий: орбитальные или внутричерепные осложнения; три признака бактериального синусита и более; иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа; 4 эпизода синусита и более за последний год.

Системная антибактериальная терапия взрослым рекомендована при наличии перечисленных показаний.

Системная антибактериальная терапия детям рекомендована при наличии перечисленных показаний.

При впервые возникшем синусите терапия начинается с незащищённых аминопенициллинов.

При высоком риске устойчивости пневмококка доза амоксициллина увеличивается. При сопутствующих заболеваниях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неэффективности ранее назначенного амоксициллина терапия начинается с защищённых аминопенициллинов.

При отсутствии заметного эффекта в течение 3 дней препарат заменяется, не дожидаясь окончания курса. У детей эффективность оценивается через 48–72 часа.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск продукции бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неэффективность предшествующей терапии амоксициллином.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7 дней, осложнённого 10–14 дней.

Макролиды являются препаратами резерва и применяются только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны допустимы только у взрослых и только при отсутствии других вариантов; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма

Препарат	Доза
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или посещает детский коллектив, а также при неэффективности амоксициллина в течение 48–72 часов. При лёгкой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы из расчёта на килограмм массы тела предназначены для детей с массой тела менее 40 кг; при массе 40 кг и более используют дозы для взрослых.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении 10–14 дней.

> В тексте КР имеется расхождение: в разделе 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей составляет 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, в таблице 5 указано 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Парентеральная терапия при тяжёлом течении

Взрослым при тяжёлом синусите вводятся цефотаксим или цефтриаксон, возможно также внутривенное введение амоксициллина с клавулановой кислотой. При риске анаэробной инфекции применяют клиндамицин в сочетании с цефалоспорином III поколения. При неэффективности стартовой парентеральной терапии рассматривается назначение цефоперазона с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, при резистентных штаммах препаратов резерва с учётом чувствительности.

Детям вводятся ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. При неэффективности этой терапии переходят на цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Рекомендуется промывание полости носа изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы применяются только в остром периоде и не более 5–7 дней.

Назначение сосудосуживающих капель при остром синусите, согласно рекомендации, абсолютно необходимо, однако срок их применения ограничен 5–7 днями из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяется.

Детям до 6 лет применяются фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды применяют у пациентов старше 12 лет в монотерапии при затяжном поствирусном синусите или в сочетании с системными антибиотиками. Детям до 12 лет монотерапия глюкокортикостероидами допустима только при сопутствующем аллергическом рините.

Для монотерапии синусита без признаков бактериальной инфекции в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты используют в сочетании с системными или в монотерапии при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффективность оценивается через 3–4 дня.

Для лечения синусита зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Введение растворов антибиотиков для инъекций в полость носа и пазухи не допускается.

При лихорадке, головной и лицевой боли применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Детям до 6 лет применяются только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым возможно назначение кетопрофена.

Возможно назначение мукоактивных препаратов, например ацетилцистеина или карбоцистеина. Перед назначением следует свериться с инструкцией, поскольку не все препараты разрешены при заболеваниях ЛОР-органов и в сочетании с антибиотиками.

Применяются растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов могут применяться для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты оправданы при сопутствующем аллергическом рините и в начальном периоде вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение могут включаться противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком течении синусита в амбулаторных условиях возможно применение комплексных гомеопатических препаратов по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги рекомендованы взрослым с острым бактериальным синуситом; местное применение оправдано при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургическое лечение

Пункция верхнечелюстной пазухи показана при рентгенологически подтверждённом наличии содержимого в пазухе и тяжёлом или среднетяжёлом течении без эффекта от системной антибактериальной терапии в течение 5–7 дней.

Детям пункция и трепанопункция выполняются только в условиях стационара; во многих случаях вместо них возможно применение синус-катетера.

Дренирование пазух, в том числе с помощью синус-катетера, выполняют при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите дренирование не показано.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях показано хирургическое лечение в условиях стационара: вскрытие пазухи и дренирование абсцесса.

Иное лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не требуются.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным заболеваниям рекомендованы местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и предрасполагающих к нему изменениях перегородки носа или латеральной стенки полости носа показано плановое хирургическое лечение.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит способствует затяжному течению синусита; в этом случае необходимы системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Лечение одонтогенного синусита хирургическое, с удалением пломбировочного материала и секвестров. Из антибактериальных препаратов предпочтительны респираторные фторхинолоны, поскольку преобладает анаэробная микрофлора.

5. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР

Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение показана при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, при отсутствии улучшения на фоне системной антибактериальной терапии в течение 3–5 дней и при прогрессирующем ухудшении состояния в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения свидетельствуют о тяжёлом течении, острый средний отит о среднетяжёлом.

Выписка осуществляется при стабильно удовлетворительном состоянии в течение не менее 3 дней.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Исправления по результатам сверки с PDF

- Удалено предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора эта дата отсутствует, она была заимствована из пересказа MedElement.
- Доза амоксициллина у взрослых «500–1000 мг» заменена двумя дозами с условием: 500 мг при отсутствии факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия назначения амоксициллина с клавулановой кислотой и цефоперазона с сульбактамом, тиамфеникол для детей в стационаре, ограничение дозы цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение для интраназальных глюкокортикостероидов у детей до 12 лет (монотерапия только при сопутствующем аллергическом рините), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Удалена фраза «КТ рутинно не нужна», поскольку в КР она отсутствует.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина: в тексте раздела 3.1 указано 50–60 мг/кг/сут, в таблице 5 указано 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 для цефтриаксона указан код АТХ J01FA09, который является кодом кларитромицина; в тексте для цефтриаксона приведён верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им, как правило, обозначается применение вне инструкции; это следует проверить по инструкции к препарату.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Интерпретация
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности являются важными, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии эффективности являются важными, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательства надлежащего качества отсутствуют
УДД 1–5	Для лечения: от 1 (систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований с метаанализом) … до 5 (только обоснование механизма действия или мнение экспертов). Для диагностики используется отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка открывается при нажатии на бейдж